

TEMA 3.9 • UROLOGÍA

Incontinencia Urinaria: Tratamiento

PERFIL EUNACOM 7.01.1.006

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El manejo de la **Incontinencia Urinaria (IU)** es un tema de alta rentabilidad en el EUNACOM, ya que requiere distinguir claramente entre los tipos de incontinencia para definir la conducta terapéutica. Aunque los tratamientos difieren, existe un paso inicial obligatorio para todos los pacientes.

Evaluación Inicial: El "Paso Cero"

Antes de iniciar cualquier tratamiento específico para la incontinencia de esfuerzo o de urgencia, es imperativo realizar un diagnóstico diferencial básico.

- **Descartar Infección del Tracto Urinario (ITU):** Toda paciente con síntomas de incontinencia debe ser evaluada con un **sedimento urinario** y un **urocultivo**. Una **Infección del Tracto Urinario** puede irritar el detrusor y simular o exacerbar una incontinencia de urgencia.
- **Historia Clínica:** Identificar si el escape de orina ocurre ante esfuerzos físicos (tos, risa, ejercicio) o si está precedido por un deseo imperioso de miccionar.

Manejo de la Incontinencia de Esfuerzo (IOE)

La IOE se produce por una falla en los mecanismos de soporte uretral o del esfínter. Su manejo es escalonado:

1. Primera Línea: Medidas No Quirúrgicas

La base del tratamiento inicial es la **Kinesioterapia Pelvica**. - **Ejercicios de Kegel:** Consisten en la contracción voluntaria repetida de los músculos del piso pélvico. - **Eficacia:** No solo son curativos en etapas iniciales, sino que funcionan como una excelente herramienta de **prevención**, especialmente en pacientes **multiparas**. Se debe educar a la paciente para realizarlos incluso antes de que aparezcan los síntomas.

2. Segunda Línea: Manejo Quirúrgico

Si la kinesioterapia falla, el tratamiento de elección es la cirugía. Actualmente, el estándar de oro es la instalación de **cintas suburetrales de tensión libre** (Slings).

TABLA 3.9.1: TÉCNICA VS ACRÓNIMO

TÉCNICA	ACRÓNIMO	DESCRIPCIÓN
Tension-free Vaginal Tape	TVT	Cinta de polipropileno colocada por vía retropúbica.
Trans-Obturator Tape	TOT	Cinta colocada a través de los agujeros obturadores (menor riesgo de lesión vesical).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para el EUNACOM, recuerda que la cirugía de la IOE busca corregir la hipermovilidad uretral mediante una cinta que levante la **uretra media**.

Manejo de la Incontinencia de Urgencia (IU)

La IU (o vejiga hiperactiva) se debe a contracciones involuntarias del músculo detrusor. El enfoque aquí es principalmente conductual y farmacológico.

1. Primera Línea: Terapia Conductual y Reentrenamiento

Antes de prescribir fármacos, se deben agotar las medidas no farmacológicas: - **Modificación de conducta:** Evitar irritantes vesicales (cafeína, alcohol), manejar la ingesta de líquidos (no tomar mucha agua antes de salir o dormir) y programar micciones preventivas. - **Reentrenamiento vesical:** El objetivo es que el

sistema nervioso central retome el control sobre el detrusor. Se instruye a la paciente a: 1. Aguantar las ganas de orinar cuando sienta la urgencia (aumentar intervalos). 2. Una vez en el baño, decidir voluntariamente cuándo iniciar la micción. 3. Practicar el corte del chorro (ocasionalmente, como ejercicio de control). - **Kinesioterapia pélvica:** Aunque es el pilar en la IOE, también tiene utilidad secundaria en la de urgencia.

2. Segunda Línea: Farmacoterapia

Se utilizan medicamentos que inhiben la contracción del detrusor o que promueven la relajación vesical.

A. Anticolinérgicos (Antimuscarínicos) Son los fármacos más utilizados. Su principal problema son los efectos adversos sistémicos (boca seca, estreñimiento, visión borrosa).

- **Oxibutinina:** Es la más barata y disponible, pero la que produce **más sequedad de boca**.
- **Tolterodina:** Similar eficacia que la oxibutinina pero con **mejor perfil de tolerancia** (menos boca seca).
- **Cloruro de Trospio:** Su gran ventaja es que **no atraviesa la barrera hematoencefálica (BHE)**.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Los anticolinérgicos clásicos pueden empeorar una **Demencia** establecida o aumentar el riesgo de deterioro cognitivo en adultos mayores. En estos pacientes, se prefiere el **Trospio** o evitar esta familia de fármacos.

- ##### B. Agonistas Beta-3 Adrenérgicos
- Representan una alternativa moderna y más segura, aunque de mayor costo.
- **Fármacos:** **Mirabegron** y **Vibegron**.
- **Mecanismo:** Estimulan los receptores Beta-3 en la vejiga, promoviendo la relajación del detrusor durante el llenado.
- **Ventaja:** No tienen efectos anticolinérgicos, por lo que son muy seguros en el adulto mayor y no se asocian a demencia.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología: Mientras los anticolinérgicos bloquean la "orden de contraerse" (vía parasimpática), los agonistas Beta-3 potencian la "orden de relajarse" (vía simpática).

Resumen de Fármacos para Incontinencia de Urgencia

TABLA 3.9.2: FÁRMACO VS CLASE

FÁRMACO	CLASE	CONSIDERACIÓN ESPECIAL
Oxibutinina	Anticolinérgico	Barato, mucha boca seca.
Tolterodina	Anticolinérgico	Menos efectos adversos que oxibutinina.
Trospio	Anticolinérgico	No cruza BHE. Seguro en riesgo de demencia.
Mirabegron	Beta-3 Agonista	Caro, muy seguro, sin riesgo cognitivo.

Consideraciones en el Adulto Mayor

El manejo en el adulto mayor requiere especial cuidado por la polifarmacia y la fragilidad cognitiva.

- Siempre buscar causas reversibles (mnemotecnía DIAPPERS: Delirium, Infección, Atrofia, Farmacología, Psicológico, Exceso de orina, Restricción de movilidad, Stool/Constipación).
- Si se requiere fármacos para urgencia, las opciones de elección por seguridad cognitiva son:

- - **Beta-3 agonistas** (Mirabegron).
- - **Cloruro de Trosipio**.
- Evitar anticolinérgicos de acción central por riesgo de inducir **Delirium** o progresión de demencia.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Mnemotecnia para Beta-3: "Mira un vejrón" (Mirabegron) $\rightarrow$ "Ya lo vi al vejrón" (Vibegron). Son los fármacos caros pero seguros para la vejiga hiperactiva.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Paciente de cuarenta y ocho años con incontinencia de esfuerzo confirmada por clínica y sin infección urinaria. Es su primera consulta y no ha recibido ningún tratamiento previo. ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada como primera línea?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Incontinencia Urinaria: Tratamiento. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La primera medida ante toda incontinencia urinaria es descartar infección urinaria activa con sedimento de orina y urocultivo
- El tratamiento de primera línea de la incontinencia de esfuerzo es la kinesioterapia pélvica, incluyendo ejercicios de Kegel; también funciona como prevención en múltiparas
- El tratamiento de segunda línea de la incontinencia de esfuerzo es quirúrgico: instalación de cinta suburetral transobturatriz o transvaginal que levanta la uretra media
- El tratamiento de primera línea de la incontinencia de urgencia es no farmacológico: terapia conductual y reentrenamiento vesical; los fármacos son segunda línea
- Los anticolinérgicos de uso en incontinencia de urgencia son oxibutinina y tolterodina; el trosipio tiene la ventaja de no atravesar la barrera hematoencefálica y es más seguro en adultos mayores
- Los beta-3 agonistas adrenérgicos como mirabegron y vibegron son muy seguros y no se asocian a demencia; son preferibles en adultos mayores aunque son más costosos
- En adultos mayores se deben evitar los anticolinérgicos clásicos que atraviesan la barrera hematoencefálica por riesgo de inducir o empeorar demencia

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (INCONTINENCIA URINARIA: TRATAMIENTO)**PREGUNTA 1**

Paciente de cuarenta y ocho años con incontinencia de esfuerzo confirmada por clínica y sin infección urinaria. Es su primera consulta y no ha recibido ningún tratamiento previo. ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada como primera línea?

- A)** Cirugía con instalación de cinta transobturatriz de primera línea por ser el tratamiento más efectivo
- B)** Oxibutinina para inhibir las contracciones del detrusor como primera línea
- C)** Kinesioterapia pélvica con ejercicios de Kegel y fortalecimiento del piso pélvico
- D)** Terapia conductual y reentrenamiento vesical como primera línea
- E)** Tamsulosina para relajar el cuello vesical como primera línea

PREGUNTA 2

Paciente de setenta y ocho años con incontinencia de urgencia confirmada. No responde a terapia conductual ni a reentrenamiento vesical. Se decide iniciar tratamiento farmacológico. ¿Cuál es el fármaco más adecuado considerando su edad y el riesgo de efectos adversos cognitivos?

- A)** Oxibutinina porque es el anticolinérgico más eficaz y económico disponible
- B)** Tolterodina porque tiene menos boca seca que la oxibutinina y es igualmente eficaz
- C)** Trosipio o un beta-3 agonista como mirabegron porque no cruzan la barrera hematoencefálica y son más seguros en adultos mayores
- D)** Antidepresivos tricíclicos porque también tienen efecto anticolinérgico sobre la vejiga
- E)** Finasteride porque reduce el tamaño de la próstata y puede mejorar la incontinencia

PREGUNTA 3

Paciente de cincuenta y cinco años con incontinencia de esfuerzo que no respondió a seis meses de kinesioterapia pélvica bien realizada. ¿Cuál es la siguiente línea de tratamiento?

- A)** Oxibutinina como segunda línea farmacológica en incontinencia de esfuerzo refractaria
- B)** Instalación de cinta suburetral transobturatriz o transvaginal que levante la uretra media
- C)** Reentrenamiento vesical como segunda línea antes de la cirugía
- D)** Tolterodina para inhibir las contracciones del esfínter uretral debilitado
- E)** Observación y control en seis meses para evaluar progresión espontánea

RESUMEN: INCONTINENCIA URINARIA: TRATAMIENTO

El tratamiento de la incontinencia urinaria depende del tipo y siempre comienza con el paso universal de descartar infección urinaria activa. Para la incontinencia de esfuerzo, el tratamiento de primera línea es la kinesioterapia pélvica, que incluye los ejercicios de Kegel y otras técnicas de fortalecimiento del piso pélvico. Esta estrategia también funciona como prevención en mujeres multíparas antes de desarrollar incontinencia. El tratamiento de segunda línea y definitivo es quirúrgico: se instala una cinta suburetral que levanta la uretra media, siendo las más usadas la cinta transobturatriz y la cinta transvaginal, ambas con muy buenos resultados. Para la incontinencia de urgencia, el tratamiento de primera línea es no farmacológico: terapia conductual que modifica hábitos como evitar el consumo de líquidos antes de salidas, y reentrenamiento vesical que entrena al cerebro para controlar mejor la vejiga, practicando aguantar cuando hay urgencia y cortar el chorro voluntariamente. Los fármacos para la incontinencia de urgencia son la segunda línea y pertenecen a dos familias. Los anticolinérgicos inhiben las contracciones no inhibidas del detrusor y los más usados son la oxibutinina, que es barata pero produce mucha sensación de boca seca, y la tolterodina, que es más cara pero con menos efectos adversos. El cloruro de trospio tiene la ventaja de no atravesar la barrera hematoencefálica, lo que lo hace más seguro en adultos mayores donde los anticolinérgicos clásicos se asocian a riesgo de demencia o empeoramiento de demencia preexistente. Los beta-3 agonistas adrenérgicos como el mirabegrón y el vibegrón son más caros y menos disponibles pero muy seguros, sin asociación con demencia, siendo preferibles en adultos mayores cuando hay recursos. En el adulto mayor se deben evitar los anticolinérgicos clásicos que atraviesan la barrera hematoencefálica por el riesgo de demencia; las opciones más seguras son el trospio y los beta-3 agonistas. En la incontinencia mixta el manejo combina las estrategias de ambos tipos. Es importante recordar que la kinesioterapia pélvica es útil también como tratamiento complementario en la incontinencia de urgencia, aunque su efecto principal es en la incontinencia de esfuerzo.